

Matriz CSD Estratégica — Projeto AGD

Visão Geral: Esta Matriz CSD (Certezas, Soluções e Dúvidas) foi consolidada com o objetivo de organizar e ampliar as premissas estratégicas do **AGD** contra os principais players mapeados no ecossistema de saúde atual (CIDIRISCO e e-SUS APS). O foco é maximizar a eficiência competitiva eliminando redundâncias e atacando falhas críticas de mercado.

Certezas	Soluções e Suposições	Dúvidas
Fatos validados pelo cenário de concorrência	Como o AGD responde às lacunas identificadas	Validações cruciais e riscos a mapear
• Nicho e Alinhamento: O AGD e o CIDIRISCO focam especificamente na vigilância de crianças de risco, enquanto o e-SUS APS possui apenas um foco geral de atuação. • Entrada Manual de Dados: 100% dos concorrentes atuais (CIDIRISCO e e-SUS APS) dependem de processos de inserção manual de dados. Gargalo de Produtividade • Fragilidade do e-SUS: O sistema nacional e-SUS APS falha na linha de frente por apresentar dados fragmentados e uma "vigilância fraca" voltada a crianças de risco, além de não emitir alertas automáticos. • Incapacidade Logística: O CIDIRISCO executa a territorialização e o encaminhamento de forma totalmente manual. O e-SUS APS apenas armazena os endereços, mas é incapaz de mapear e identificar as USFs mais próximas. Defasagem Geográfica	• Propósito Humano do AGD: Mais do que uma plataforma técnica, o AGD irá cuidar ativamente daquelas crianças de risco que hoje acabam esquecidas e invisíveis no sistema de saúde devido às graves falhas e lacunas de automação hospitalar dos concorrentes. Impacto Social & Cuidado • Automação Inteligente: O AGD elimina o preenchimento manual capturando dados diretamente dos sistemas e bases de dados de saúde existentes no Recife. Diferencial AGD • Algoritmo de Roteirização: Soluciona o apagão logístico ao geolocalizar o usuário, encaminhá-lo de forma automatizada para a USF mais próxima e traçar em tempo real a rota mais curta. • Vigilância Ativa 360°: Substitui a vigilância falha através de um monitoramento contínuo (dentro e fora do hospital), operacionalizado por dashboards em tempo real no aplicativo.	• Superação Histórica: De que forma estratégica o AGD irá competir com o CIDIRISCO no curto prazo, considerando que eles detêm uma base de dados histórica acumulada e já fundamentada? • Resistência Institucional: Como mitigar eventuais barreiras regulatórias ou corporativas ao expandir o AGD para fora de Recife, visto que o e-SUS APS é a ferramenta oficial e soberana do Ministério da Saúde? Desafio de Escala • Infraestrutura de Campo: Qual é a real capacidade técnica (aparelhos móveis, conectividade 3G/4G/5G) e o nível de letramento digital dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para operar o dashboard externo com eficiência? • Abrangência das Bases: A integração com as "bases de dados hospitalares" descrita no escopo cobrirá integralmente a rede pública estadual, conveniada e a rede privada, ou ficará restrita aos leitos municipais de Recife?

Certezas Fatos validados pelo cenário de concorrência	Soluções e Suposições Como o AGD responde às lacunas identificadas	Dúvidas Validações cruciais e riscos a mapear
• Barreiras de Integração: O CIDIRISCO gera dados isolados e enfrenta sérias dificuldades de unificação por não possuir nenhuma integração com o sistema PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão). • Experiência do Usuário (UX): O mercado sofre com usabilidade defasada. A interface do CIDIRISCO é considerada obsoleta e a do e-SUS APS possui navegação complexa. • Patrimônio de Dados: O CIDIRISCO está consolidado no mercado graças a uma base de dados histórica e altamente fundamentada.	• Fortalecimento Humano: Integração direta da tecnologia com o trabalho de campo realizado pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). • Interoperabilidade Total: Neutraliza o isolamento de dados integrando-se nativamente ao Conecta Recife, ao ecossistema do SUS, ao sistema PEC e a bases de dados de hospitais. Arquitetura Conectada • Vantagem de Engajamento: Entrega de uma interface intuitiva e moderna, projetada sob medida para reduzir a fricção e aumentar a aderência dos profissionais.	• Sincronização com o PEC: Como mitigar o risco de latência na atualização dos dados entre o AGD e o sistema PEC para garantir que o monitoramento ocorra de fato em tempo real?